

SISTEMA SEVEIAAS 2026

PROY-NOM-045-SSA-2026

Vigilancia Epidemiológica

Protocolos de Vigilancia y Manejo de IAAS en Unidades Neonatales

Detección oportuna, definiciones estandarizadas, estratificación obligatoria y cálculo exacto de tasas en menores de 1 año.

| Contexto y Propósito de la Vigilancia



Objetivos Clave

Detectar oportunamente casos, brotes y tendencias; identificar factores de riesgo inherentes a neonatos para guiar el uso racional de antibióticos.



Áreas de Alcance

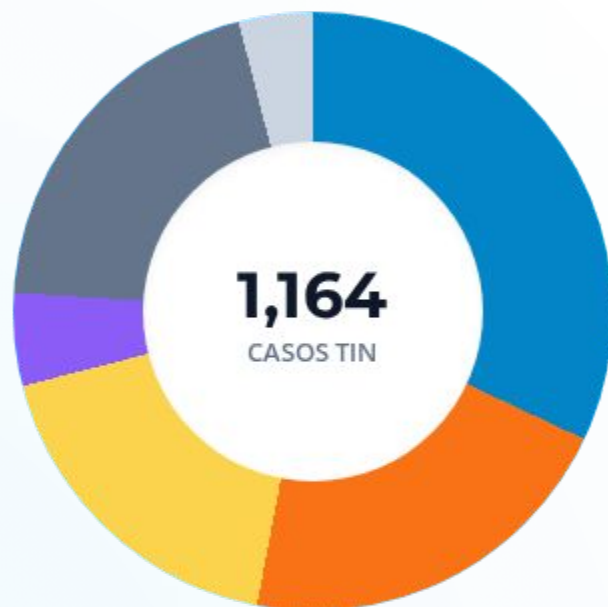
Obligatorio en todas las unidades médicas, con énfasis absoluto en TIN (UTIN), cuidados intermedios, quirófanos, lactarios y banco de leche.



Efectividad

Evaluar de manera continua el cumplimiento y la efectividad real de las medidas de prevención implementadas (como las fijaciones seguras).

Distribución de Eventos IAAS en TIN



- ITS-CC (32%)- Principal causa de infección
- NAV (21%)- Segundo evento de mayor peso
- IVU-CU (18%)- Asociadas a catéter urinario
- Piel y tejidos blandos (5%)
- Otras IAAS (20%)- Sepsis clínica, oftalmía, etc.
- Otros (4%)

* Datos epidemiológicos oficiales consolidados nacionales para el grupo de menores de 1 año (12.4% de la carga nacional de IAAS).

Indicadores y Carga Epidemiológica

Estratificación de la Carga	Porcentaje / Distribución
Distribución por Sexo	57% Hombres 43% Mujeres
Por Peso: $\leq 1,500$ gramos	61% de los casos en UTIN
Por Peso: $> 1,500$ gramos	39% de los casos en UTIN
Carga Global Menores 1 año	3,389 casos (12.4% nacional)

Tasa / Indicador Nacional	Límite de Referencia Máximo
Incidencia Global de IAAS	2.4 por cada 100 egresos
Tasa de NAV	≤ 12.0 por 1,000 días-ventilador
Tasa de ITS-CC	≤ 2.6 por 1,000 días-catéter
Tasa de IVU-CU	≤ 3.0 por 1,000 días-catéter urinario

** Letalidad total asociada documentada en el periodo de análisis: 2.8%*

| Microorganismos Prevalentes Registrados



E. coli representa el patógeno bacteriano más común y destructivo. La presencia de *C. difficile* genera requisitos estrictos de sanitización especial por la escasa eficacia de las soluciones alcohólicas ante esporas.

| Monitoreo de Resistencia

Vigilancia de Patrones Críticos

Es mandatorio identificar y reportar de manera inmediata cepas con resistencia extendida en la unidad neonatal:

- **MRSA:** *S. aureus* resistente a meticilina.
- **KPC:** *K. pneumoniae* productora de carbapenemasas.
- **Gramnegativos MDR:** *P. aeruginosa* multirresistente y *E. coli* productora de BLEE.

Red Nacional de Vigilancia (InDRE): Las unidades deben enviar cepas representativas de brotes para análisis molecular y emitir un informe de forma anual al COVEPCIAAS.



| Definiciones Operacionales Clínicas

IAAS Adquirida vs Importada

- ⚠ **IAAS Adquirida en la Unidad:** Sintomatología o cultivos positivos que inician **≥ 48 horas** posteriores al ingreso del paciente, sin estar en incubación previa.
- ⚠ **IAAS Importada:** Caso con manifestaciones clínicas o aislamiento microbiológico positivo detectado dentro de las primeras **< 48 horas** post-ingreso a la sala actual.

Infección Congénita (No IAAS)

-  **Definición:** Infección de origen materno-fetal, identificable al momento del nacimiento o en las primeras **< 72 horas** de vida extrauterina.
-  **Exclusión Normativa:** Este tipo de eventos son considerados perinatales o congénitos y se encuentran **excluidos de las tasas** de IAAS de la unidad neonatal.

| Estratificación Obligatoria de Datos

Estratificación por Peso

- **Extremadamente bajo peso:** Pacientes con peso corporal menor o igual a **1,000 g**.
- **Muy bajo peso:** Lactantes con rangos de peso entre **1,001 g** y **1,500 g**.
- **Bajo peso y normal:** Subdivididos en **1,501 g a 2,500 g** y pesos superiores a **2,500 g**.

Edad y Tipo de Unidad

- **Estratificación por Edad:** Clasificación en tres cohortes estrictas: de **0 a 7 días** de vida, de **8 a 28 días** y periodo de lactante de **29 a 365 días**.
- **Tipo de Servicio:** Separar los datos por tipo de sala: Terapia Intensiva (TIN), Cuidados Intermedios o Pediatría General.

| Cálculo de Tasas y Registro Diario

Es obligación documentar diariamente en la unidad: días estancia (DE), egresos, fallecimientos, días de ventilación mecánica (DVM), días con catéter central (DCC) y días con catéter urinario (DCU).

Densidad de Incidencia (IAAS) $Tasa = \frac{\text{Número de Casos de IAAS específicos}}{\text{Total Días-Dispositivo del mismo periodo}} \times 1,000$

Tasa de Incidencia Global $Tasa = \frac{\text{Total de IAAS diagnosticadas}}{\text{Total de Egresos Hospitalarios}} \times 100$

** Los datos deben ser ingresados de forma directa y sin omisiones en el sistema SEVEIAAS, manteniendo bases validadas sin rezagos.*

| Flujo de Información y Alerta de Brotes



La investigación de brotes requiere de forma obligatoria la búsqueda activa de casos, identificación de fuentes comunes y establecimiento inmediato de medidas de contención microbiológica.

| Soporte Crítico de Laboratorio



Estrategia diagnóstica microbiológica: La toma de muestras debe ser mínimamente invasiva, calculando estrictamente el volumen sanguíneo de acuerdo al peso del neonato.



Prioridad de cultivos: Procesamiento veloz de hemocultivos, urocultivo, aspirado traqueal y exudados locales.



Tiempo de respuesta (TAT): Reporte preliminar en ≤ 24 horas y resultados definitivos en un lapso no mayor a **48 horas**.



Control de Calidad: Participación obligatoria en esquemas internos y externos, asegurando el resguardo de cepas críticas por un periodo mínimo de **6 meses**.

Conclusiones y Consolidación

La vigilancia activa y el registro preciso son determinantes en la seguridad del paciente neonatal.

ESTANDARIZACIÓN 2026

El PROY-NOM-045-SSA-2026 unifica criterios bajo estándares CDC y OPS, erradicando confusiones operativas entre colonización e infección activa.

ESTRATIFICACIÓN POR PESO

La obligatoriedad de separar la información por peso neonatal asegura tasas comparables y realistas a nivel nacional en grupos de alto riesgo.

CULTURA DE REPORTE

El cumplimiento estricto del reporte semanal y la activación del protocolo de brote en menos de 24 horas salvan vidas en unidades críticas.

EFFECTIVIDAD CLÍNICA

Las tasas de IAAS no son solo números; son el reflejo de la calidad de nuestras técnicas de sujeción, asepsia y cuidado diario.

Bibliografía y Fuentes del Módulo de

- Proyecto de Norma Oficial Mexicana **PROY-NOM-045-SSA-2026** Vigilancia epidemiológica, prevención y control de infecciones asociadas a la atención de la salud.
- Reporte Epidemiológico Trimestral de las IAAS, 2026. Secretaría de Salud, Dirección General de Epidemiología. México.